콜레스테롤 결과지, 이렇게 읽으세요

콜레스테롤은 같은 수치라도 **내 위험인자와 앓고 있는 병**에 따라 약을 시작하는 기준이 다릅니다.

1 결과지의 숫자 4개 — 무엇을 뜻하나요

항목	이렇게 보세요	결과지 기준(mg/dL)†
총콜레스테롤	여러 콜레스테롤을 **모두 합친 값** — 좋은 HDL이 높아도 올라갑니다	적정 <200 · 높음 ≥240
LDL '나쁜'	혈관벽에 쌓여 **심근경색·뇌졸중**을 일으킴 — **약은 이 숫자로 정합니다**	적정 <100 · 높음 ≥160
HDL '좋은'	혈관에 쌓인 콜레스테롤을 간으로 되돌림 — **낮을수록** 나쁩니다	낮음 <40
중성지방	식사·술·체중에 따라 크게 변함 — 500 이상이면 **급성 췌장염** 위험	적정 <150 · 높음 ≥200

2 중성지방은 생활습관, LDL은 체질의 영향이 큽니다

중성지방 = 생활습관의 신호
탄수화물·단 음료·술·체중에 따라 오르내립니다. 체중을 3~5% 줄이면 약 15 mg/dL 내려갑니다.

LDL = 간이 만드는 양(체질)
간이 만들고 치우는 능력이 크게 좌우합니다. 같은 감량에도 약 5 mg/dL 내려가는 데 그칩니다.

중성지방은 낮은데 LDL만 높다면 — 생활습관보다 **체질(유전)** 쪽일 가능성이 큽니다. 내 탓은 아니지만 생활습관만으로는 덜 내려가, 위험도에 따라 약을 함께 생각합니다.

3 약은 언제? — 내 위험인자부터 세어 보세요

위험인자 5가지 — ① 나이(남 45세·여 55세 이상) ② 고혈압(수축기 140 또는 이완기 90 이상, 또는 혈압약) ③ 흡연 ④ HDL 40 미만 ⑤ 부모·형제의 이른 협심증·심근경색* · HDL 60~100이면 1개 빼기

나의 상황	LDL 목표	약을 고려	약 시작
위험인자 0~1개	<160	130~159	160 이상
위험인자 2개 이상	<130	100~129	130 이상
당뇨 (10년 미만 · 위험인자 없음)	<100	70~99	100 이상
당뇨(10년 이상, 또는 위험인자·장기 손상) · 동맥경화성 뇌경색·일과성 뇌허혈 · 경동맥·다리 동맥 질환**	<70 · 50%↓	55~69	70 이상
협심증·심근경색(스텐트 포함) · 동맥경화성 심혈관질환이 있는 당뇨	<55 · 50%↓	55 미만도 고려	55 이상

심근경색이 막 생겼다면 수치와 관계없이 바로 약 · **LDL 190 이상**은 다른 원인(갑상선기능저하 등)을 확인하고, 없으면 위험인자와 관계없이 약 · **위험인자 0~1개·2개 이상인 분**은 몇 주~몇 달 생활요법을 먼저 하고도 높을 때 약 시작(이때 타고나는 수치인 **Lp(a)**가 50 mg/dL 이상이면 더 적극적으로) · † 결과지 범위는 개인 위험도를 따지지 않은 기준 · * 남 55세·여 65세 전 발병 · ** 알부민뇨·신장 기능(eGFR) 60 미만·망막병증·신경병증·좌심실비대 · 당뇨는 위험인자 개수에 넣지 않음 · 50%↓ = 치료 전의 절반 이하로

4 생활요법 6가지

1. **밥·빵·면·단 음료**를 너무 많이 먹지 않기
2. **통곡물·잡곡·채소**로 식이섬유 하루 25 g 이상
3. **기름진 고기·버터·튀김·배달음식** 줄이기 (포화지방·트랜스지방)
4. 단백질은 **생선·콩**으로, 가공육·붉은 고기는 줄이기
5. **술은 가급적 끊기** — 마시더라도 하루 1~2잔 이내
6. **숨이 약간 찰 정도**의 유산소 주 150~300분, **근력운동 주 2~3회**

5 LDL을 올리는 커피 기름(카페스톨)



에스프레소
아메리카노·라떼 **중간**

동결건조
인스턴트 **적음**

종이필터 드립
필터가 거름 **적음**

동결건조·드립은 둘 다 거의 없음 · 가장 많은 것은 끓인 커피·튀르키예식

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

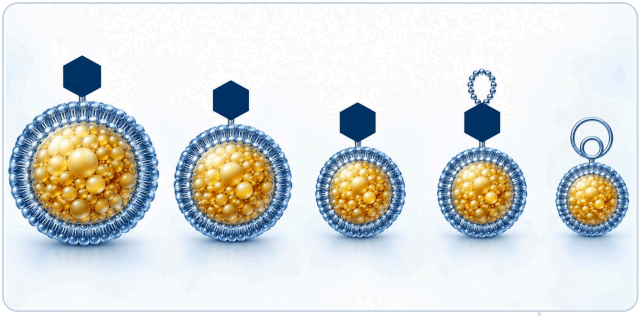
근거 — 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 · 커피 디테르펜(Food Chem Toxicol 1997 · Annu Rev Nutr 1997 · Open Heart 2022)

교육·참고용 안내문입니다. 내 목표와 약 시작 여부는 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정합니다. ***뒷면 → ApoB·Lp(a)·HDL·약을 끊어도 되나요?***

결과지의 새 항목, 그리고 약 — 자주 묻는 질문

LDL이 목표에 닿아도 **남아 있는 위험**을 보는 검사가 ApoB와 Lp(a)입니다.

6 LDL이 괜찮은데 ApoB는 왜 또 보나요? — 나쁜 입자의 개수를 셉니다



VLDL	IDL	LDL	Lp(a)	HDL
가장 큼	중간	나쁜	꼬리 달림	좋은
나쁜 입자마다 ApoB 이름표 1개				ApoA1

- 나쁜 입자는 크기가 달라도 ApoB 이름표가 하나씩 붙어 있어, ApoB를 재면 **나쁜 입자의 개수**를 알 수 있습니다.
- LDL 말고도 VLDL·IDL 같은 **다른 나쁜 입자까지** 모두 함께 셉니다.
- 좋은 HDL에는 ApoA1이라는 다른 이름표가 붙습니다. **ApoB가 ApoA1에 비해 적을수록** 좋습니다.
- LDL이 목표에 닿았는데 **ApoB가 높으면 약을 더 쓸지** 의논합니다.

언제 재나요? 매번 재는 검사는 아닙니다. 당뇨·대사증후군이 있거나 중성지방이 높아 LDL 숫자만으로는 위험을 가늠하기 어려울 때 잽니다.

7 Lp(a)가 높다는데, 어떻게 하나요? — 한 번 재고, LDL을 더 낮춥니다

먼저 결과지의 단위를 보세요. Lp(a)는 검사실마다 nmol/L 또는 mg/dL로 나오고, 두 칸은 서로 바꿔 계산한 값이 아닙니다. **내 결과지 단위 칸만** 보세요.

구분	nmol/L로 나왔다면	mg/dL로 나왔다면	이렇게 봅니다
낮음	75 미만	30 미만	Lp(a) 때문에 위험이 늘 가능성은 낮습니다
회색지대	75 이상~125 미만	30 이상~50 미만	경계 — 혈압·흡연·가족력 같은 다른 위험인자와 함께 봅니다
높음	125 이상	50 이상	**위험 증가** — LDL을 더 낮게, 혈압·혈당·담배도 함께 관리

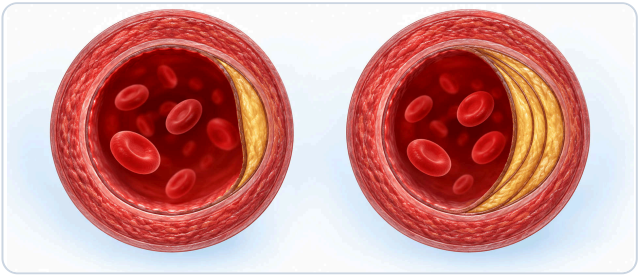
- Lp(a)는 90% 이상 타고나는 수치라 식사·운동으로 잘 바뀌지 않습니다. 성인이 되면 **적어도 한 번** 재 보면 됩니다.
- 수치가 높으면 **부모·형제·자녀도 재 볼지** 의논하세요. 스타틴(콜레스테롤 약)은 Lp(a)는 못 낮춰도 LDL을 낮춰 주니 계속 드세요.

8 HDL은 높을수록 좋은 거 아닌가요? — 아주 높다고 더 좋지는 않습니다

40 미만 mg/dL	**40~59**	**60~100**	**100 넘음**
위험인자로 셉니다	보통 — 더하지도 빼지도 않음	보호 — 위험인자 1개 빼기	보호로 치지 않음 — 아주 높으면 위험이 다시 오를 수 있음

9 수치가 좋아졌는데 약을 끊어도 되나요? — 혼자 끊지 마세요

- 수치가 좋아진 것은 **약이 일하고 있다는 뜻**입니다. 스타틴을 끊으면 1~2일부터 LDL 말고 다른 보호 효과가 줄고, 2~3개월 뒤에는 LDL도 치료 전으로 돌아갑니다. 심근경색·뇌경색 직후에 끊으면 더 위험합니다.
- 혈관 손상은 **LDL이 얼마나 높았고 얼마나 오래였는지**만큼 쌓입니다. 약을 쉬었다 다시 먹으면 그사이 높았던 기간이 그대로 더해집니다.
- 가벼운 근육통·혈당이 걱정되면 **끊기 전에 먼저 상의**하세요 — 근육통은 약 때문인지 확실하지 않을 때가 많고, 혈당이 조금 올라도 예방 효과가 훨씬 큽니다.
- 단, **심한 근육통·힘 빠짐·콜라색 소변**이면 약을 멈추고 바로 진료받으세요(진료시간 밖이면 응급실).



꾸준히 복용 ●●●●●●

쉬었다 다시 복용 ●××●×●

× = 약을 쉬어 LDL이 높았던 기간

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

근거 — 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 · 유럽동맥경화학회 Lp(a) 합의문(Eur Heart J 2022) · ApoB 입자(JAMA Cardiol 2019) · ApoB/ApoA1(Lancet 2008) · LDL 노출(Eur Heart J 2017) · 스타틴 이상 증상(MedlinePlus 2026)

교육·참고용 안내문입니다. 검사 여부와 약 조절은 결과와 위험도를 보고 진료실에서 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/cholesterol-result-reading/